



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : حمديه محمود محمد زياده
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الهرم
رقم البطاقة : 25510062300348 رقم التليفون : 01111817644
العمر (تاريخ الميلاد) : 06-10-1955 المهنة : ربه منزل
العنوان : -----
تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الاروماتيز [14161]
قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حمدية محمود محمد ذباده National ID: 25510062300348	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

سوننا، بلخني و صوهي
 ائمة على الاعمال
 اعبا ٭ و فطومات

هنا هو جرد

د م م



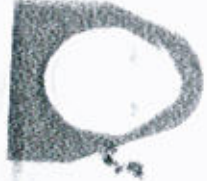
٢٠١٣/٧ ربة منزل ٢٥٥١٠٠٦٢٣٠٠٣٤٨

متروجة
 انثى
 النور صالح محمد زياده
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٠/١٢/٢٥





FN4691671



جمهورية دولة فلسطين
 وزارة الداخلية
 دائرة التسجيل



٢٥٥١٠٠٦٢٣٠٠٣٤٨

حديثة
 محمود محمد زياده
 ع ١ - مجودة ٤ - الخي
 ١ اكوير تان - الجيزة

Dr.
Deaa Fekri Khater
M.Sc., M.D., Pathology
Ass. Prof. of Pathology
Helwan University



دكتور
ضياء فكري خاطر
دكتوراه تحليل الأنسجة والأورام - أستاذ الباثولوجي بكلية الطب - جامعة حلوان
استشاري تحليل الأنسجة والأورام - مستشفى الأورام

PATHOLOGY REPORT

Patient name : حمالة محمد

Code No; 590/20

Age; 64 y

Gender; Female

Date; 20/3/2020

Referred by P : د/ عبد مصطفى

CLINICAL DATA:

Left breast mass, upper outer quadrant

NATURE OF SPECIMEN:

Tru cut core biopsy

GROSS:

Three greyish fleshy tissue cores, longest measured 1cm long, totally processed.

MICROSCOPY:

Examination of sections prepared from the specimen received showed cores of tumor tissue formed of groups of malignant ductal cells, showing moderate nuclear pleomorphism and hyperchromasia, moderate attempt at tubular differentiation and exhibiting low mitotic index. Moderate surrounding desmoplasia is noted.

No tumoral necrosis.

No intraductal element in material received.

DIAGNOSIS:

Left breast mass, Tru cut core biopsy;

Invasive ductal carcinoma, (ductal NOS), Grade II.

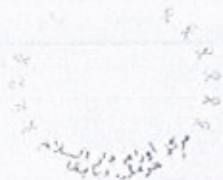
Pathologist

Dr. Deaa Khater

1 slide enclosed

بريد: القاهرة - شارع الدخلة - برج 3 - الدور الرابع - أعلى طابق العيادة الأولى - ومطعم زوسكو القديم 01555567012





Name: **HAMDYA MAHMOUD**

Date: **03-05-2020**

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Left breast speculated mass lesion is seen measuring about 3 x 2.3 cm with overlying skin thickening.
- Multiple enlarged left axillary pathological lymph nodes are seen, the largest one measures about 21 x 14 mm.
- Right upper lobe insignificant 4 mm nodule is noted.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Dorsal spondylosis.
- Small hiatus hernia.
- Right thyroid calcified nodule is noted.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- Left breast speculated mass lesion with overlying skin thickening.
- Multiple enlarged left axillary pathological lymph nodes.
- Right upper lobe insignificant 4 mm nodule.

DR, Ibrahim Elsedawy, M.Sc, FEBR

Dr, m.gomaa, md



Patient Name: Hamdeya Mahmoud Mohamed Zeyada	Date : 08/02/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 68 Year(s)
Medical ID: 1511/2020	32433

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Best regards,

Dr/Asmaa Zoinhom, Msc

Not Approved

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

حمديه
محمود محمد زياده

ع ١ - مجاورة ٤ - الحي ١١
٦ أكتوبر ثان - الجيزه

١٩٥٥/١

٢٥٥١٠٠٦٢٣٠٠٣٤٨

IS5668113

